

Tests hépatiques:

- Intégrité hépatoc. : ASAT, ALAT (transaminases)
- Cholestase: Phosphatase alcaline, γ -GT (γ -glutamyl transpeptidase)
- Fonct. de synthèse et d'éliminat. : TP, albumine, bilirubine

Transaminases:

↑ Si stress hépatique.

- Aspartate amino-transf. (ASAT, GOT): cytosol et mitoc. hépatocyte, pas spéc. du foie (aussi cœur, muscle, rein, cerveau, pancréas).
- Alanine amino-transf. (ALAT, GPT): cytosol hépatocyte. Spéc. du foie → diagn. hépatites.

Rapport ASAT/ALAT:

- < 1 : majorité lésions hépatiques aiguës
- > 2 : hépatite alcoolique, cirrhose hépatique, maladie de Wilson fulminante. Es clair pourquoi ASAT + élevée.

Phosphatase alcaline: (Pa)

- Isoenzymes divers (foie/voies biliaires, os, placenta → + élevée pdt grossesse et croissance).
- Bon marqueur pbm cholestatique, lésions focales, infiltratives ou granulomateuses, sepsis,...

γ -glutamyl transpeptidase: γ GT

- Enzyme microsomiale
- Cholestase et cytolysé
- Induct. microsomiale (alcool, phénytoïne, barbiturates, ...) → élevée, mais fa baisse.
- Aide à distinguer si ↑ Pa due au foie ou autre. Si 2 sont élevés + probable que problème cholestatique. Si γ -GT pas élevée, - probable. Sensible, mais pas spéc.

Tests sanguins spécifiques:

- Sérologies pour les hépatites virales
- Coeff. de saturat. de la transferrine, ferritine
- Ceruloplasmine*, cuprurie (maladie Wilson). * transporteur de cuivre
- α 1-antitrypsine → smooth muscle antibody
- Auto-Ig (ANA, SMA, AMA, ...)

Marqueurs hépatiques:

- AFP: α -foeto-proteïne: marqueur tumoral pour CHC. Qd ⊕ à un certain taux → hautement suspect.
- Corps de Mallory-Denk: marqueur histologique. Condensat. de filaments interm. ds hépatite alcoolique (et NAFLD)